



PLEURÉSIE PURULENTE

Dr A. Alioua

Maitre assistante en pneumophtisiologie
Centre hospitalo-universitaire de
Constantine

OBJECTIF

- ❑ Définir une pleurésie purulente
- ❑ Décrire les signes cliniques et radiologiques des pleurésies purulentes
- ❑ Décrire les formes évolutives et les principales complications des pleurésies purulentes
- ❑ Décrire la conduite à tenir devant une pleurésie purulente



PLAN

- I. Définition
- II. Intérêt de la question
- III. Anatomie pathologie
- IV. Pathogénie
- V. Diagnostic positif
- VI. Diagnostic Etiologique
- VII. Traitement
- VIII. Evolution
- IX. Conclusion



I. DÉFINITION

- C'est la présence dans la cavité pleurale d'un liquide d'aspect louche, trouble, ou franchement purulent, contenant une majorité des polynucléaires neutrophiles (PN) altérés (Empyème)



II. INTÉRÊT DE LA QUESTION

- ❑ Les pleurésies purulentes compliquent l'évolution d'environ
2 à 5 % des pneumonies
- ❑ Problème diagnostic bactériologique et thérapeutique
- ❑ Gravité: terrain sous jacent



III. ANATOMIE PATHOLOGIE

La pleurésie purulente passe par trois phases:

1- Phase exsudative

- Liquide louche et libre.
- Plèvre inflammatoire, congestive, rougeâtre , mince et souple.
- Guérison sans séquelle possible

2. Phase de collection :

- Liquide franchement purulent et plus épais.
- Les deux plèvres qui sont épaissies, rigides.
- Cloisonnement rapide avec accumulation dans la partie postéro-inférieure.



III. ANATOMIE PATHOLOGIQUE

3- Phase d'enkystement

- Liquide purulent, enkysté par la symphyse pleurale.
- Plèvre sclérosée (pachypleurite) avec accolement des 2 feuillets.
- Lésions souvent irréversibles.



ANATOMIE PATHOLOGIE

Phase exsudative



Phase de
collection



Phase
d'enkystement



IV. PATHOGÉNIE

1 -Facteurs favorisants

A -Généraux

- Tabagisme/Ethylisme
- Diabète
- Dénutrition
- Immunodépression
- Troubles de déglutition

B -Foyer de porte d'entrée

- Orl /Mauvaise hygiène buccodentaire/Sinusite infectieuse
 - Cutanée
 - Obstruction bronchique
- 

IV. PATHOGÉNIE

2- Mécanisme de survenue

- Pleurésie purulente secondaire à un foyer septique pulmonaire :
 - pneumonie, abcès, DDB suppurée
- Pleurésie purulente par inoculation directe:
 - Plaie pénétrante
 - Ponction / biopsie iatrogène
 - Post-thoracotomie
- Pleurésie purulente par inoculation indirecte:
 - Fistule bronchique
 - Fistule œsophagienne
 - abcès sous phrénique
 - Abcès hépatique
- Voie hématogène(Endocardite infectieuse)



V. DIAGNOSTIC POSITIF

1- Clinique:

- ❑ Le début brutal++
- ❑ un syndrome infectieux + altération importante de l'état général
 - Fièvre élevée avec frissons.
 - Douleurs thoraciques
 - Toux sèche
 - dyspnée parfois cyanose.



❑ Examen physique : **Trépied de Trousseau**

- Inspection : immobilité relative d'un héli thorax –
- Palpation : diminution ou abolition des vibrations vocales
- Percussion : une matité franche, déclive.
- Auscultation : diminution ou abolition du murmure vésiculaire

- ❑ L'examen doit être compléter par l'examen de la cavité buccale et la sphère ORL



2- Examens paraclinique

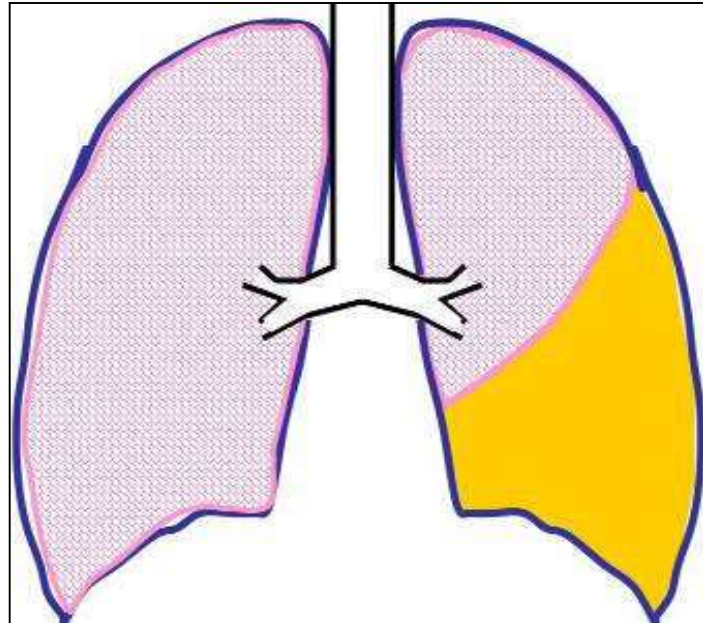
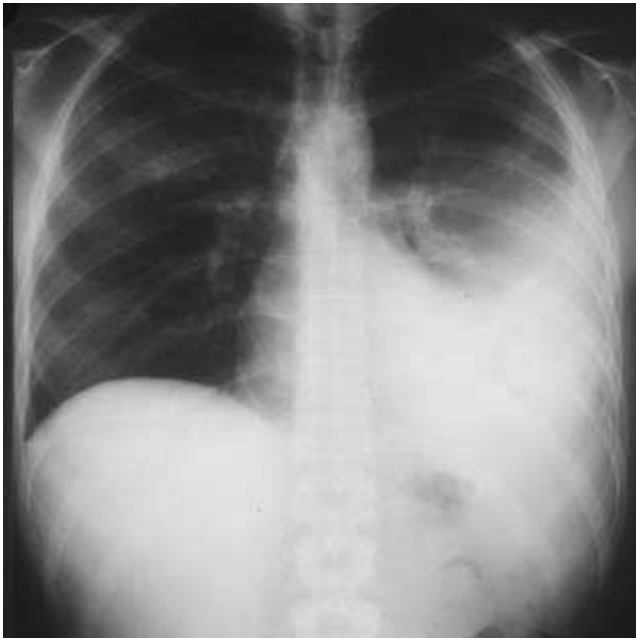
A- Radio du thorax F/P:

En fonction du stade en aura

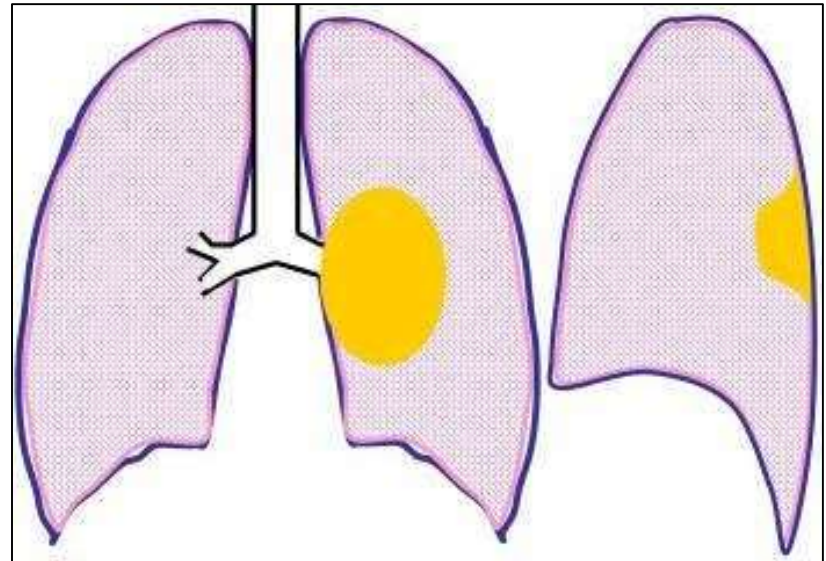
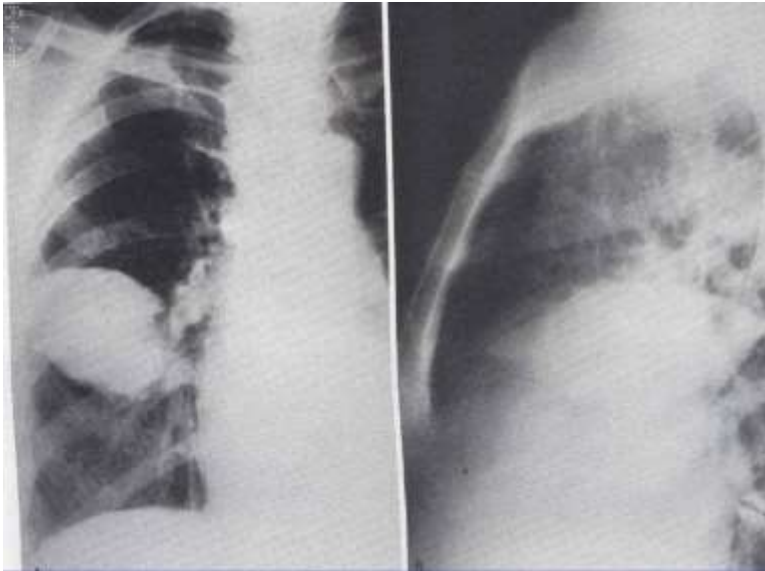
- **Stade de diffusion:** image d'un épanchement pleural libre à limite supérieure concave en haut et en dedans
- **Stade de collection:** opacité en forme de ménisque basithoracique axillaire ou postérieure
- La présence de niveau liquide évoque des germes anaérobies ou une fistule.



Pleurésie libre



Pleurésie enkystée



B- Echographie thoracique:

De plus en plus utilisée ++

- Faire le diagnostic et apprécier la nature de l'épanchement (cloisonnement)
- Guider la ponction pleurale et le drainage thoracique

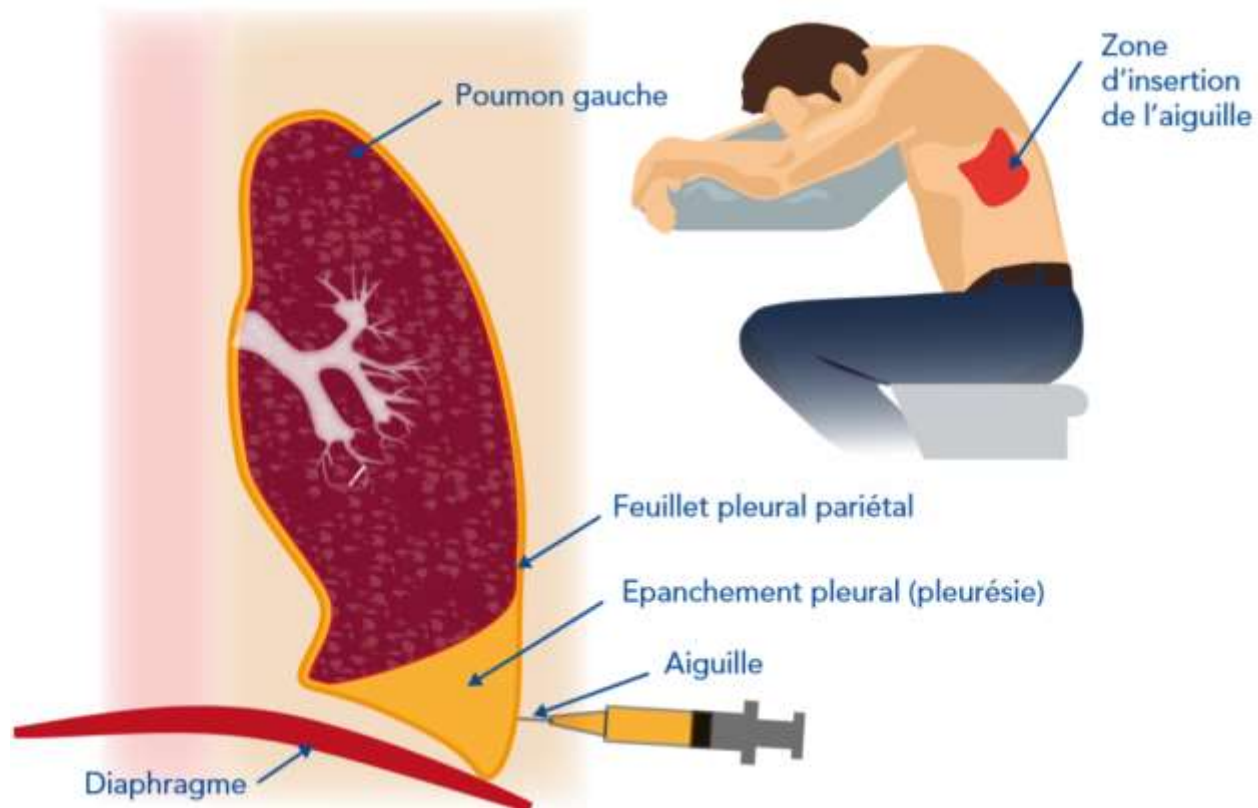


C- Ponction pleurale : Examen clé ++

- La ponction pleurale confirme le diagnostic
- Effectuée avant toute antibiothérapie avec une
aiguille de calibre suffisant.
- S'effectue en pleine matité



PONCTION PLEURALE



- Macroscopie: un liquide louche ou purulent, épais, parfois fétide (anaérobies)
- Etude biochimique: au stade de purulence
 - **exsudatif**
 - $\text{PH} < 7,20$
 - Taux de LDH $> 1000 \text{ u/l}$
 - Glycopleurie $< 0,4\text{g/l}$
- Etude cytologique: prédominance de **PNN altérés**.
- Etudes bactériologique:
 - Examen direct et culture (aérobie et anaérobie)
 - Recherche des BK par examen direct et culture
 - Antibiogramme

**Liquide pleural
d'aspect purulent**



D- BILAN GÉNÉRAL

○ Biologie

- FNS: Hyperleucocytose à PNN
- CRP élevée
- Hémocultures
- ECB de l'expectoration, prélèvements endobronchiques protégés
- Bilan selon le Terrain: diabète , insuffisance rénale , sérologie

○ Autres

- Prélèvement au niveau d'une porte d'entrée
- TDM thoracique : Topographie /rechercher un foyer parenchymateux.
- Echographie abdomino-pelvienne
- Fibroscopie : rechercher une cause locale
- EFR et gazométrie: évaluation de retentissement



VI. DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

Selon le germe

1-Pneumocoque:

- Pneumopathie sous-jacente quasi constante
- Tendance au cloisonnement très rapide..

2 - Streptocoque:

- Chercher surtout un foyer ORL, cutané ou dentaire

3- Staphylocoque:

- Terrain :Diabète ,toxicomanes
- Pneumopathie sous-jacente souvent extensive, abcédée, bilatérale, avec tableau grave et détresse respiratoire



VI. DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

4- Entérobactéries (BGN):

- Escherichia coli, klebsiella, Proteus..
- Résistance aux ATB : traitement en fonction de l'antibiogramme: quinolone, céphalosporine, aminosides

5- Germes anaérobies :

- Bactéroïdes, Fusobacterium, Peptostreptococcus... etc.
- Terrain : mauvais état dentaire, sujet éthylique
- Fétidité de l'épanchement et de l'expectoration.
- Pouvoir nécrosant ++

6- Bacille tuberculeux :

- Rarement incriminé, doit être recherché systématiquement.



VII. TRAITEMENT

Traiter l'infection
(Antibiothérapie)

Traitement local
(Evacuer la plèvre)

kinésithérapie

Traiter le terrain



VII. TRAITEMENT

1- Traitement général :

- **Antibiothérapie** : Initialement probabiliste en IV :
Amoxicilline/acide clavulanique ou (Céphalosporine 3^{ème} G) +
Métronidazole
- Elle sera ensuite adaptée selon le résultat des prélèvements
bactériologiques.
- D'une durée de 3 à 6 semaine



2- Traitement local :

- Évite le passage à la constriction par pachypleurite.
 - Stade de diffusion : ponction avec une aiguille de gros calibre et lavage au sérum physiologique.
 - Stade d'enkystement : Drainage après repérage échographique et/ou scannographique et lavage au sérum physiologique.



3- Kinésithérapie respiratoire et pleurale :

- A débiter précocement, but faciliter le drainage bronchique + la ré-expansion pulmonaire.

4- Traitement chirurgical:

- Une décortication Soit une pleuro-éxerèse



5 -Mesures associées :

- Recherche et éradication d'un foyer infectieux
- Correction des troubles hydro-électrolytiques et nutritionnelles
- Traitement d'une pathologie associée



VIII. EVOLUTION

❑ Evolution favorable :

- Le traitement précoce: évite l'évolution vers l'enkystement.

❑ Evolution défavorable:

- Pachypleurite avec insuffisance respiratoire restrictive
- Des rétractions pleurales
- Bronchectasie
- Des fistules broncho-pleurales.



IV. CONCLUSION

- ❑ La pleurésie purulente est une affection grave survenant chez les sujets fragiles.
- ❑ Leur prise en charge est avant tout hospitalière .
- ❑ Leur traitement préventif repose sur le traitement correct de toute pneumopathie notamment chez les sujets avec comorbidités



Merci de votre attention

